

Dossier bibliográfico para inspección sanitaria: demora en prueba de imagen ante lumbalgia irradiada y posible déficit motor

Resumen ejecutivo

Objeto y delimitación. El usuario no ha especificado cuál es exactamente “esa pregunta”. Conforme a las opciones indicadas en el encargo, las hipótesis temáticas plausibles serían: **infección nosocomial, vacunación, uso de antimicrobianos y manejo de urgencias/consentimiento informado**. La **asunción formal del dossier sigue siendo: tema no especificado**. No obstante, los tres documentos aportados permiten identificar una cuestión operativa mucho más probable para la inspección: **si la asistencia, reevaluación, priorización y realización de una resonancia magnética lumbar fueron temporal y clínicamente adecuadas ante una lumbalgia con irradiación y aparición referida de “menos fuerza” en una pierna en junio de 2025**, así como si se proporcionó y documentó adecuadamente el *safety-netting* o información sobre motivos de reconsulta. Ese foco se aproxima a la opción de “manejo de urgencias”, pero no debe confundirse con una confirmación de que esa fuera la pregunta original.

La documentación disponible es deliberadamente incompleta. El 2 de junio de 2025 consta una consulta por dolor lumbar de varios días de evolución; el extracto señala que “se explican motivos de reconsulta”, pero no los detalla, no contiene una exploración neurológica completa y no registra petición de imagen en esa anotación. [filecite:turn0file1](#) La reclamación añade que el dolor se extendía a una pierna y sostiene que la explicación sobre cuándo volver a consultar fue insuficiente. [filecite:turn0file2](#)

El reclamante sitúa el comienzo de la sensación de “menos fuerza” el **10 de junio** y recuerda que la prueba se solicitó ese mismo día. [filecite:turn0file2](#) El extracto asistencial del **11 de junio** sí recoge persistencia del dolor y “sensación de menor fuerza desde el día anterior”, junto con la indicación “reevaluar y derivar para valoración”, pero no cuantifica fuerza mediante escala MRC ni incorpora el informe de esa valoración posterior. [filecite:turn0file1](#) El registro administrativo sitúa el asiento de la solicitud de imagen el **12 de junio a las 09:10**, pero advierte expresamente que **no figura la fecha de emisión clínica ni está disponible el formulario clínico original**. La cita se asignó el 16 de junio y la prueba se realizó el 24. [filecite:turn0file0](#)

Por tanto, según qué fecha se utilice, transcurrieron **14 días desde el inicio referido de la debilidad hasta la resonancia, 13 días desde la anotación clínica del 11 de junio, 12 días desde el asiento administrativo del 12 de junio y 8 días desde la asignación de cita del 16 de junio**. Esos intervalos son verificables documentalmente, pero **por sí solos no permiten declarar adecuada ni inadecuada la demora**: la conclusión depende de si existía una radiculopatía no complicada o, por el contrario, un déficit motor objetivo, significativo o progresivo, o signos sugestivos de síndrome de cauda equina.

La evidencia disponible **antes del 30 de junio de 2025** establece una bifurcación muy relevante para la inspección:

Escenario de bajo riesgo. En lumbalgia aguda, incluso con radiculopatía, **sin signos de alarma**, la realización inmediata y rutinaria de pruebas de imagen no mejora los resultados clínicos; NICE desaconseja la imagen rutinaria en entornos no especializados y ACR considera la RM inicial “usually not appropriate” en lumbalgia aguda con o sin radiculopatía y sin *red flags*. ¹ En este escenario, una RM realizada a las pocas semanas no representa necesariamente una demora perjudicial; incluso puede ser más precoz de lo aconsejado para una lumbalgia no complicada.

Escenario de alto riesgo. Esa evidencia **no es trasladable** a un paciente con déficit neurológico grave o progresivo o sospecha de cauda equina. ACR considera la RM lumbar apropiada como estudio inicial ante sospecha de cauda equina, y el ACP ya reservaba la imagen avanzada para, entre otros supuestos, déficit neurológico grave/progresivo o sospecha de patología grave. ² El itinerario nacional inglés GIRFT para cauda equina, disponible desde 2023, también la trata como una emergencia que requiere diagnóstico y tratamiento sin demora. ³

La palabra **“menos fuerza” es, por ello, el pivote del expediente**. No equivale automáticamente a una paresia clínicamente objetivable. Sin exploración de fuerza bilateral y por grupos musculares, grado MRC, reflejos, sensibilidad, marcha y evolución temporal, no puede saberse en qué rama de la evidencia se encontraba realmente el paciente.

Además, la evidencia contemporánea sobre **déficit motor por hernia discal** no era completamente uniforme. En un subgrupo aleatorizado de pacientes con ciática de 6–12 semanas y déficit MRC 3–4, la cirugía temprana aceleró la recuperación motora, pero a un año la recuperación completa fue prácticamente igual —81% frente a 80%—. ⁴ En cambio, estudios prospectivos observacionales más recientes disponibles ya en 2021–2022 asociaron una descompresión muy temprana, especialmente dentro de aproximadamente 72 horas/3 días, con mejor recuperación de paresias moderadas o graves. ⁵ La discrepancia obliga a **estratificar por intensidad, progresión y repercusión funcional del déficit** y desaconseja utilizar una regla retrospectiva única para todo paciente que verbalice “menos fuerza”.

Desde el punto de vista documental y jurídico, la Ley 41/2002 reconoce el derecho del paciente a recibir información comprensible sobre las actuaciones asistenciales y establece que, como regla general, la información verbal debe dejar constancia en la historia clínica; además, exige integrar en ésta la anamnesis, exploración física, evolución, órdenes, interconsultas e informes de exploraciones complementarias. ⁶ Que el extracto disponible diga “se explican motivos de reconsulta” prueba que existe esa anotación, pero **no permite verificar qué signos de alarma se explicaron**; tampoco su ausencia del extracto demuestra que no se explicasen. Esa distinción probatoria es esencial.

Finalmente, el Real Decreto 605/2003 define, a efectos del sistema estatal de información sobre listas de espera, la **Prioridad 1 para pruebas diagnósticas como una solicitud preferente que debe realizarse en un máximo de 15 días**. ⁷ Sin embargo, el propio Real Decreto aclara que esas definiciones se establecen **a efectos de los datos del registro del SNS**, y distingue la asistencia programada de la urgencia clínica. ⁸ Por ello, que los 12 días entre asiento administrativo y RM estén dentro de 15 días **no resuelve la cuestión clínica** si lo que realmente existía era una emergencia neurológica.

Conclusión provisional: con D1–D3 **no hay base suficiente ni para afirmar negligencia/demora indebida ni para descartarla**. El punto decisivo de inspección no es “¿se tardaron doce días?”, sino: **¿qué déficit neurológico existía realmente, cuándo apareció, cómo evolucionó, qué signos de alarma se investigaron y documentaron, qué prioridad clínica se asignó, cuándo se emitió realmente la solicitud, qué mostró la RM y qué consecuencia clínica tuvo el intervalo?**

Metodología de búsqueda

Se realizó una **búsqueda bibliográfica dirigida y estructurada**, cerrada a **25 de septiembre de 2026**, separando de forma estricta la información **disponible hasta el 30 de junio de 2025** de la publicada posteriormente. No debe presentarse como una revisión sistemática PRISMA exhaustiva con exportación completa de todas las bases bibliográficas: su finalidad es un **dossier técnico para inspección**, orientado a localizar evidencia contemporánea y documentos normativos de mayor fuerza y aplicabilidad.

Se priorizaron, en este orden, **fuentes oficiales españolas y autonómicas**, normativa estatal, guías de práctica clínica de organismos públicos o profesionales con metodología explícita, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ensayos clínicos y estudios prospectivos originales. Se consultaron BOE, GuíaSalud/SNS, AQuAS-Essencial, NICE, ACR, recursos oficiales de NHS/GIRFT y registros PubMed de los artículos originales. GuíaSalud constituye el catálogo y marco de GPC del SNS, mientras que Essencial es una iniciativa autonómica catalana de adecuación y reducción de prácticas de poco valor. ⁹

Los conceptos de búsqueda combinaron equivalentes españoles e ingleses de: *lumbalgia, dolor lumbar, ciática, radiculopatía, déficit motor, debilidad, paresia, Medical Research Council/MRC, resonancia magnética, pruebas de imagen, signos de alarma, síndrome de cauda equina, retención urinaria, post-void residual, timing of surgery, lumbar disc herniation, early imaging, delayed imaging, safety-netting, listas de espera, prioridad diagnóstica e historia clínica*.

Para la aplicabilidad se utilizó una valoración cualitativa del nivel de evidencia:

Categoría utilizada en este dossier	Interpretación
Alta	Metaanálisis de ECA o evidencia experimental consistente y directamente aplicable al escenario estudiado.
Moderada	ECA/subgrupo aleatorizado o estudio prospectivo robusto, pero con limitaciones de población, indirectitud o precisión.
Baja-moderada	Cohorte prospectiva no aleatorizada susceptible a confusión por indicación, aunque clínicamente informativa.
Baja	Cohortes retrospectivas, auditorías o estudios muy seleccionados; útiles para generar hipótesis, no para establecer por sí solos causalidad.
Normativa/GPC	No equivale a un “nivel” experimental; se valora por autoridad, metodología, vigencia y correspondencia con el caso.

Hay dos límites metodológicos importantes. Primero, **no se conoce la comunidad autónoma ni el centro asistencial**, por lo que no es posible determinar qué norma autonómica de garantías de demora, protocolo regional de RM o circuito local de cauda equina era vinculante en junio de 2025. El RD 605/2003 remite a las comunidades autónomas la información relativa a garantías de demoras máximas y sus anexos tienen finalidad de homogeneización del sistema de información. ⁸ Segundo, la evidencia publicada después del 30 de junio de 2025 se utiliza únicamente para comprobar si el conocimiento posterior **confirma, matiza o contradice** el disponible en la fecha de los hechos; **no se utiliza retrospectivamente para redefinir lo que un profesional debía conocer en junio de 2025**.

Evidencia disponible hasta el 30-06-2025

Marco clínico: la imagen precoz depende de que existan o no signos de alarma

El hallazgo más consistente de la literatura es que **“imagen precoz” no puede evaluarse de forma aislada de la situación neurológica**. El metaanálisis de Chou et al. incluyó ensayos de pacientes con lumbalgia sin indicios de patología grave y no encontró mejorías significativas de dolor o función con imagen lumbar inmediata frente a manejo habitual; los autores concluyeron que los resultados son aplicables fundamentalmente a lumbalgia aguda/subaguda sin rasgos de enfermedad subyacente grave. ¹⁰

El ensayo multicéntrico de Gilbert et al., con 782 pacientes derivados a especialistas, comparó imagen temprana con una política selectiva/diferida. La imagen temprana produjo cambios pequeños y no transformó de forma importante el manejo global; la población tampoco constituye un modelo de emergencia neurológica con déficit progresivo. ¹¹ En otras palabras, estos trabajos son fuertes contra la **RM indiscriminada**, pero no justifican demorar la RM cuando aparece una indicación urgente.

NICE NG59 establece que no debe ofrecerse rutinariamente imagen a personas con lumbalgia o ciática en un entorno no especializado y que, en servicios especializados, debe considerarse únicamente cuando sea probable que el resultado cambie la conducta clínica. ¹² ACR ofrece una distinción aún más explícita: en lumbalgia aguda con o sin radiculopatía **sin red flags**, la RM inicial es habitualmente inapropiada; ante **sospecha de síndrome de cauda equina**, la RM lumbar sin contraste o sin/con contraste es habitualmente apropiada. ¹³

La recomendación española histórica de Essencial sobre pruebas de imagen en lumbalgia se publicó originalmente en 2013, aunque su texto web actualmente visible fue actualizado en abril de 2026; por ello, **los detalles de la versión 2026 no deben atribuirse retrospectivamente a la versión que existía en junio de 2025**. ¹⁴ La antigua GPC de Osakidetza sobre lumbalgia, incorporada a GuíaSalud, tenía valor histórico español, pero el propio catálogo advertía de su antigüedad, por lo que no es una base suficiente para fijar aisladamente la *lex artis* de 2025. ¹⁵

Déficit motor por hernia discal: evidencia relevante pero heterogénea

En el ensayo Sciatica de Peul et al., 283 pacientes con ciática intensa de 6–12 semanas fueron aleatorizados a cirugía temprana o tratamiento conservador prolongado. La cirugía produjo alivio más rápido del dolor y recuperación percibida más rápida, pero los resultados a un año fueron semejantes. ¹⁶ Esta evidencia se refiere a pacientes seleccionados con varias semanas de evolución, no a sospecha aguda de cauda equina.

Más directamente pertinente es el subanálisis de Overvest et al.: 150 pacientes del ensayo tenían déficit motor, generalmente MRC 4 y, en una minoría, MRC 3. La cirugía temprana aceleró la recuperación del déficit, pero a las 52 semanas la recuperación completa fue **81% con cirugía temprana frente a 80% con tratamiento conservador prolongado**; un déficit inicial más intenso y una hernia que ocupaba mayor proporción del canal se asociaron con persistencia del déficit. ⁴

Esa conclusión se matizó posteriormente mediante cohortes prospectivas de pacientes quirúrgicos. Kögl et al. observaron que, en déficits moderados o graves por hernia discal lumbar, la cirugía realizada dentro de las primeras 72 horas se asociaba con mayor recuperación motora que la cirugía posterior.

¹⁷ Thomé et al. estudiaron prospectivamente a **390 pacientes** operados por hernia discal con déficit motor; la intensidad preoperatoria —especialmente MRC $\leq 2/5$ — y la duración de la paresia fueron

fuertes predictores, y la cirugía en los primeros tres días se asoció con mejor recuperación; un análisis de sensibilidad situó alrededor de ocho días el punto de corte para déficits leves. ¹⁸ Son estudios muy relevantes, pero **no aleatorizados**: quien es operado inmediatamente puede diferir de quien lo es más tarde, y todos los pacientes ya habían sido seleccionados para cirugía.

Para una inspección, la síntesis correcta no es “cualquier debilidad exigía una RM en 72 horas”, sino: **a junio de 2025 existían razones científicas serias para no tratar un déficit motor objetivamente importante o progresivo como una radiculopatía banal**, y había evidencia observacional de que la duración del déficit podía importar para la recuperación. La intensidad MRC, la progresión y la repercusión funcional son imprescindibles para trasladar esa literatura al expediente. ¹⁹

Síndrome de cauda equina y valor de los signos de alarma

La cauda equina plantea un problema adicional: los síntomas clásicos no son suficientemente sensibles para descartarla individualmente. La revisión sistemática de Dionne et al., con siete estudios y 569 participantes, encontró sensibilidades agrupadas de los signos/síntomas estudiados de aproximadamente **0,19-0,43** y especificidades de **0,62-0,88**; la presencia de *red flags* justifica investigación diagnóstica rápida, pero su ausencia aislada no constituye un test de exclusión potente. ²⁰

El residuo posmiccional (PVR) puede ayudar, pero tampoco sustituye a la valoración clínica. Katzouraki et al., en 260 pacientes con sospecha de cauda equina, encontraron que $PVR \geq 200$ ml ofrecía una sensibilidad de 94,1%, especificidad de 66,8% y valor predictivo negativo de 98,7% en aquella cohorte.

²¹ Una metaanálisis posterior de 2023, con siete estudios y 1.083 pacientes, encontró para 200 ml una sensibilidad agrupada aproximada de 82% y especificidad de 65%, y advirtió contra su utilización aislada como herramienta de exclusión. ²² Además, Todd et al. documentaron casos de cauda equina incompleta confirmada por RM con PVR inferior a 200 ml, reforzando que un resultado bajo no elimina por sí solo la necesidad de RM cuando la historia y exploración generan sospecha. ²³

Para este expediente no consta información sobre retención urinaria, dificultad para iniciar micción, alteración de la sensación urinaria, incontinencia, función intestinal, anestesia perineal/en silla de montar, síntomas bilaterales ni residuo posmiccional. ²⁴ Esa ausencia **en el extracto** constituye una laguna de información crucial; no permite afirmar ni que los signos estuvieran presentes ni que hubieran sido interrogados y fueran negativos.

Marco normativo y documental aplicable en España

La Ley 41/2002 establece que la información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, ha de ser verdadera, comprensible y adecuada a las necesidades del paciente y, como regla general, se facilita verbalmente dejando constancia en la historia clínica. ²⁴ Para este caso, la frase del 2 de junio “se explican motivos de reconsulta” es pertinente, pero su carácter genérico en el extracto impide comprobar si se explicó volver inmediatamente ante debilidad progresiva, síntomas esfinterianos, alteración perineal u otros signos de alarma. ²⁵

La misma Ley exige incorporar a la historia la información trascendental para conocer de forma veraz y actualizada el estado de salud, y menciona expresamente anamnesis, exploración física, evolución, órdenes médicas, interconsultas e informes de exploraciones complementarias. El personal sanitario de inspección debidamente acreditado puede acceder a la historia para comprobar la calidad asistencial y el respeto de los derechos de los pacientes. ²⁵ Esto apoya que una inspección no debería basarse sólo en D1-D3 si existen los documentos originales.

Respecto a la demora administrativa, el RD 605/2003 define como “fecha de entrada en el registro” **la fecha de indicación de la prueba por el médico peticionario**. ⁸ Esa definición hace especialmente relevante la aparente discordancia con D3: el documento denomina al 12 de junio “fecha de registro de solicitud”, pero aclara que se trata de un **asiento administrativo** y que no dispone de la fecha de emisión clínica. ²⁶ Antes de equiparar “12/06” con la fecha normativa de indicación es imprescindible recuperar la orden electrónica y su trazabilidad.

El anexo III del RD 605/2003 denomina **Prioridad 1 o preferente** a la solicitud de consulta/prueba que debe realizarse en un máximo de 15 días. ⁷ No obstante, el Real Decreto advierte que las definiciones de sus anexos se establecen únicamente para los datos del registro del SNS. ⁸ A su vez, el RD 1039/2011 no establece una garantía estatal general específica de “X días” para cualquier RM lumbar: su anexo estatal de tiempos máximos garantizados enumera determinadas intervenciones quirúrgicas, no una garantía universal para resonancias. ²⁶ Por ello habrá que identificar la **CCAA y su normativa vigente en junio de 2025**.

Comparativa de guías y fuentes regulatorias disponibles a la fecha crítica

Fuente	Año/ estado a 30-06-2025	Diseño/ámbito	Población o supuesto	Recomendación/ resultado relevante	Nivel / peso para este dossier	Aplicación expediente
Ley 41/2002	2002, vigente	Ley básica estatal	Pacientes del sistema sanitario	Derecho a información; constancia en HC; anamnesis, exploración, evolución, órdenes, interconsultas e informes deben integrarse según proceda. ⁶	Normativo alto	Clave para valorar exploración neurológica <i>safety-net</i> y trazabilidad documental
RD 605/2003	2003, vigente	Norma estatal de información de listas de espera	Consulta/ pruebas programadas	Prioridad 1: ≤15 días; fecha de entrada definida como fecha de indicación médica; anexos dirigidos al registro del SNS. ²⁷	Normativo, no estándar de emergencia	Los 12 días podrían en “preferente” pero esto resuelve clínicamente debía ser un circuito urgente
NICE NG59	2016, actualizada 2020	GPC	Lumbalgia/ ciática >16 años	No imagen rutinaria en ámbito no especializado; considerarla si cambia el manejo. ¹²	GPC, alta autoridad metodológica	Apoya no hacer RM precoz si hay red

Fuente	Año/ estado a 30-06-2025	Diseño/ámbito	Población o supuesto	Recomendación/ resultado relevante	Nivel / peso para este dossier	Aplicación expediente
ACR Appropriateness Criteria	2021	Guía de adecuación radiológica	Dolor lumbar, diferentes variantes	Sin <i>red flags</i> : imagen inicial habitualmente inapropiada. Sospecha de cauda equina: RM habitualmente apropiada. ¹³	GPC/ consenso basado en evidencia	Muy útil distinguir dos hipótesis del caso.
ACP	2011	High-value care advice	Dolor lumbar	Imagen avanzada reservada, entre otros supuestos, a déficit neurológico grave/ progresivo o sospecha de enfermedad grave. ²⁸	GPC basada en evidencia	La gravedad progresiva "menos fuerza" e determina
GIRFT/NHS CES pathway	2023	Itinerario multidisciplinario nacional inglés	Sospecha de cauda equina	Considera CES una emergencia y estructura investigación, imagen y tratamiento sin demora. ³	Guía operativa oficial extranjera	Corroborar no jurídica vincular España.
Osakidetza, GPC lumbalgia	2007	GPC española histórica	Lumbalgia en AP	Marco nacional/ autonómico histórico, pero GuíaSalud advertía de su antigüedad. ¹⁵	Baja vigencia en 2025	No debe ser fuente decisiva aislada.

Estudios primarios y revisiones de mayor relevancia antes del corte

Autor, año	Diseño	Población	Comparación/ intervención	Resultado principal	Nivel de evidencia para la pregunta	Conclusión inspectora
Gilbert et al., 2004	ECA multicéntrico	782 pacientes derivados por patología lumbar	Imagen temprana frente a política selectiva	Beneficios clínicos pequeños; sin transformación sustancial del manejo global. ¹¹	Moderada	No demuestra beneficio de RM rutinariamente precoz; limitada aplicabilidad si hay déficit progresivo.
Chou et al., 2009	Revisión sistemática/metaanálisis	Lumbalgia sin indicios de enfermedad grave	Imagen inmediata vs atención sin imagen inmediata	Sin diferencias significativas relevantes en dolor/función. ¹⁰	Alta para lumbalgia no complicada	No puede extrapolarse a <i>red flags</i> .
Peul et al., 2007	ECA	283 pacientes con ciática 6–12 semanas	Cirugía precoz vs conservador prolongado	Recuperación y alivio más rápidos con cirugía; resultados a 1 año similares. ¹⁶	Moderada–alta , pero indirecta	Distingue rapidez de recuperación de resultado final.
Overvest et al., 2014	Subgrupo de ECA	150 pacientes con ciática y MRC 3–4	Cirugía precoz vs conservador	Recuperación motora más rápida; completa a 1 año 81% vs 80%. ⁴	Moderada	Contradice una regla absoluta de que todo déficit leve/moderado exige cirugía inmediata.
Dionne et al., 2019	Revisión sistemática diagnóstica	569 sospechas de CES	<i>Red flags</i> frente a RM	Sensibilidad baja de signos individuales. ²⁰	Moderada	Un signo negativo aislado no descarta CES con seguridad.
Katzouraki et al., 2020	Prospectivo diagnóstico	260 sospechas de CES	PVR + clínica frente a RM	PVR ≥ 200 ml: sensibilidad 94,1%, especificidad 66,8% en la cohorte. ²¹	Moderada	PVR útil como complemento, no sustituto de exploración/RM.

Autor, año	Diseño	Población	Comparación/ intervención	Resultado principal	Nivel de evidencia para la pregunta	Conclusión inspectora
Kögl et al., 2021	Prospectivo, no aleatorizado	Hernia lumbar con déficit motor	Cirugía ≤72 h vs posterior	Mayor recuperación en déficits moderados/ graves operados precozmente. 17	Baja– moderada	Hace especialmente importante conocer MRC y duración del déficit.
Todd et al., 2022	Serie/ auditoría de casos CES confirmados	Casos de CES con RM positiva	PVR <200 ml	Hubo CES incompleta con PVR ≤200 ml. 23	Baja , pero alerta de seguridad	No excluir CES únicamente por PVR bajo.
Thomé et al., 2022	Prospectivo observacional	390 operados con déficit motor	Tiempo desde paresia hasta cirugía	Gravedad/ duración predijeron recuperación; ≤3 días asociado a mejor recuperación. 18	Baja– moderada	Refuerza urgencia en déficit importante, sin fijar una regla universal causal.
Revisión PVR, 2023	Metaanálisis diagnóstico	7 estudios, 1.083 pacientes	Diferentes umbrales PVR	200 ml mejor rendimiento; sensibilidad agrupada 82%, especificidad 65%; no usar aisladamente. 22	Moderada	La historia/ exploración siguen siendo imprescindibles.

Evidencia publicada después del 30-06-2025

La evidencia posterior **no modifica la lógica principal existente en junio de 2025**; más bien la refuerza: no se recomienda la imagen precoz indiscriminada en lumbalgia/radiculopatía sin alarma, mientras que el déficit neurológico relevante y la sospecha de compresión grave requieren un circuito diferente.

La actualización de **Essencial/AQuAS de abril de 2026**, fuente oficial autonómica española, establece expresamente que en personas con lumbalgia —con o sin radiculopatía— y **sin signos de alarma**, no se recomienda imagen durante las primeras cuatro a seis semanas. La misma recomendación identifica como circunstancias que justifican imagen la sospecha de patología grave y, específicamente, **déficits neurológicos graves o progresivos**, infección, cáncer o fractura. ²⁹ Esta actualización es extraordinariamente útil para interpretar el caso, pero por su fecha debe clasificarse como **evidencia**

posterior, no como norma clínica que pueda atribuirse retrospectivamente al profesional de junio de 2025.

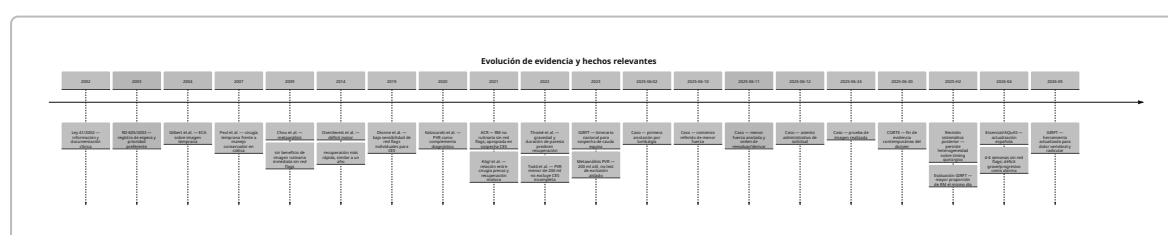
GuíaSalud publicó en marzo de 2026 una recomendación SEMFYC de no solicitar o repetir imagen en pacientes con **dolor crónico** cuando no existan signos de alarma o cambios en la patología. ³⁰ Su aplicabilidad directa aquí es baja porque el episodio de junio era agudo/subagudo, pero confirma el principio transversal de evitar imagen sin una indicación que cambie el manejo.

Una revisión sistemática publicada en 2025 sobre las indicaciones de cirugía frente a tratamiento conservador en hernia discal lumbar encontró que la cirugía temprana —con definiciones muy variables, desde 48 horas hasta varias semanas— tendía a asociarse con mejor recuperación en pacientes con déficit motor, pero subrayó una **heterogeneidad muy alta en la definición de déficit, indicaciones y umbrales temporales**. ³¹ Esta heterogeneidad refuerza precisamente la necesidad de no convertir la frase subjetiva “menos fuerza” en un umbral quirúrgico sin disponer del grado MRC y la evolución.

También después del corte se publicaron datos de implementación del itinerario GIRFT para sospecha de cauda equina. Una evaluación comunicada oficialmente por GIRFT en diciembre de 2025 comparó dos periodos de seis meses, con 175 y 159 RM urgentes respectivamente; tras implantar el itinerario, aumentó la proporción de RM realizadas el mismo día del 53% al 62%, descendieron los ingresos del 57% al 43% y la proporción de estudios que confirmaban CES se mantuvo en torno al 4%. ³² Al tratarse de una evaluación observacional de servicio en Inglaterra, es evidencia de organización asistencial, no un estándar español ni un ensayo de resultados neurológicos.

En mayo de 2026 GIRFT publicó además una herramienta para atención primaria alineada con el National Back and Radicular Pathway, destacando la identificación de *red flags* y la diferenciación entre casos de emergencia, prioritarios y no urgentes. ³³ De nuevo, sirve de comparación internacional, no de norma vinculante española.

El significado global de la evidencia posterior es, pues, **confirmatorio y no revolucionario**: la gran cuestión sigue siendo clasificar correctamente al paciente.



Comparación y discrepancias

La principal discrepancia no se da entre “una guía que exige RM y otra que la prohíbe”, sino entre **poblaciones distintas**. Cuando se confunden estas poblaciones, la literatura parece contradictoria; cuando se separan, gran parte de la contradicción desaparece.

Cuestión	Fuente/posición A	Fuente/posición B	Explicación de la discrepancia	Impacto para inspección
RM inmediata en lumbalgia	Metaanálisis y guías: no aporta beneficio sin <i>red flags</i> . ¹	RM apropiada ante sospecha de CES o patología grave. ³⁴	No son recomendaciones incompatibles: se refieren a riesgos diferentes.	Es obligatorio reconstruir signos de alarma antes de juzgar los 12–14 días.
“Menos fuerza”	Puede ser percepción subjetiva de dolor/ inhibición y no necesariamente paresia objetiva.	Un déficit MRC objetivable, progresivo o funcionalmente incapacitante puede exigir evaluación urgente. Estudios prospectivos relacionan el tiempo con recuperación. ⁵	Falta el dato que clasifica al paciente: examen neurológico.	No debe inferirse gravedad desde la reclamación ni banalizarse sin haber documentado exploración.
Cirugía temprana y recuperación motora	Overdevest: más rápida, pero 81% vs 80% de recuperación completa al año. ⁴	Kögl/Thomé: mejor recuperación con intervalos muy cortos en déficits importantes. ⁵	Diferente diseño, momento evolutivo y gravedad; ECA frente a cohortes quirúrgicas seleccionadas.	No existe base para aplicar automáticamente un único umbral a todo déficit.
Valor de PVR en sospecha CES	Cohorte prospectiva: PVR ≥ 200 ml mostró alto VPN. ²¹	Casos confirmados y metaanálisis: un PVR < 200 no excluye CES; usarlo sólo como complemento. ³⁵	Diferencias de prevalencia, espectro clínico y riesgo de falsos negativos.	Un PVR bajo —si se hubiera medido— no justificaría por sí solo una demora si persistían otros signos.
Plazo administrativo de 15 días	RD 605: Prioridad 1 preferente ≤ 15 días. ⁷	Una emergencia neurológica exige un circuito clínico distinto; el propio RD limita sus definiciones al registro informativo. ⁸	Estándar administrativo $\neq$ necesidad clínica urgente.	No declarar “cumplimiento clínico” sólo porque la prueba se hizo en 12 días.
Fecha de solicitud	D1: paciente recuerda solicitud el 10/06. filecite turn0file2	D3: asiento administrativo 12/06 a las 09:10; fecha de emisión clínica ausente. filecite turn0file0	Recuerdo del paciente frente a metadato administrativo incompleto.	Recuperar orden original y <i>audit trail</i> ; no elegir una fecha por presunción.

Cuestión	Fuente/posición A	Fuente/posición B	Explicación de la discrepancia	Impacto para inspección
Información de reconsulta	D2: “se explican motivos de reconsulta”. filecite[turn0file1]	D1: reclamante considera insuficiente la explicación. filecite[turn0file2]	Una frase genérica no permite reconstruir contenido; percepción posterior tampoco demuestra ausencia de información.	Revisar nota íntegra, material entregado y contenido concreto; Ley 41/2002 exige información adecuada y constancia. 24

La discrepancia temporal del propio expediente

El RD 605/2003 utiliza como “fecha de entrada en el registro” la **fecha de indicación médica**. 8 D3, por el contrario, advierte que su fecha de 12 de junio es un **asiento administrativo** y que la fecha de emisión clínica no se contiene en el extracto. filecite[turn0file0] Esa aparente incompatibilidad no debe resolverse mediante interpretación semántica. Puede significar que el extracto D3 usa una terminología local diferente de la del RD, que existió una orden previa pendiente de registro, o que ambas fechas coinciden y sencillamente falta el campo en el extracto. La única forma fiable de resolverlo es mediante el formulario original y los registros informáticos de creación, firma, envío, recepción y modificación.

La discrepancia con mayor impacto causal

La reclamación atribuye a la demora la prolongación de molestias y de limitación laboral y refiere una baja del **3 de junio al 15 de julio**, pero no incorpora partes oficiales ni cuantificación del daño. filecite[turn0file2] A la vez, D2 señala que no se incorpora el informe original de imagen ni la documentación completa de derivación o incapacidad temporal. filecite[turn0file1]

Sin conocer qué mostró la RM, no puede siquiera confirmarse documentalmente la entidad que el reclamante denomina “un problema de disco”. filecite[turn0file2] Mucho menos puede establecerse que realizar la RM unos días antes hubiese cambiado el tratamiento o acortado la incapacidad. La causalidad exige, como mínimo, correlacionar **déficit clínico → lesión anatómica → oportunidad terapéutica perdida → evolución posterior**. La evidencia de imagen rutinaria en lumbalgia no complicada muestra que adelantarla no mejora por sí mismo el pronóstico, mientras que la evidencia de déficit motor significativo sugiere que una demora puede importar en determinados subgrupos. 36

Por ello, la inspección debe evitar dos errores simétricos: considerar que **cualquier demora es causalmente perjudicial** o considerar que **cualquier RM dentro de 15 días es necesariamente adecuada**.

Datos del expediente necesarios

La inspección debería solicitar preferentemente **documentos fuente y metadatos**, no sólo nuevos extractos narrativos. La Ley 41/2002 contempla la integración de exploraciones, evolución, órdenes e

informes en la historia y habilita el acceso inspector para comprobar calidad asistencial y obligaciones del centro. 25

Bloque de información	Campos concretos que deberían recuperarse	Razón de relevancia
Identificación clínica básica	Edad en junio de 2025; sexo; talla/peso si relevantes; antecedentes de patología lumbar, hernia discal, cirugía vertebral o déficits neurológicos previos.	Determinar riesgo basal y diagnósticos alternativos.
Factores de alarma por enfermedad grave	Antecedentes oncológicos; inmunosupresión; infección reciente; fiebre; bacteriemia; consumo de drogas IV; corticoterapia; traumatismo; osteoporosis; anticoagulación; pérdida ponderal; cirugía/procedimiento reciente.	Distinguir radiculopatía no complicada de infección, tumor, fractura/hematoma u otra causa grave.
Cronología exacta del dolor	Fecha y, cuando sea posible, hora de comienzo; localización; irradiación; lateralidad; distribución dermatomérica; intensidad; cambios entre 2, 10, 11, 12 y 24 de junio.	Reconstruir evolución temporal y coherencia con raíz afectada.
Cronología exacta de debilidad	Primer momento de sensación subjetiva de debilidad; súbita/progresiva/ fluctuante; actividades afectadas — caminar, escaleras, caída del pie, ponerse de puntillas/talones—; fecha de cada empeoramiento o mejoría.	Es el dato central para decidir urgencia y aplicabilidad de la evidencia quirúrgica.
Fuerza motora objetiva	MRC 0-5, bilateral, idealmente para flexión de cadera, extensión de rodilla, dorsiflexión de tobillo, extensión del hallux y flexión plantar; raíz presumida L2-S1; repetición seriada de medidas.	Permite distinguir sensación subjetiva, MRC 4, MRC 3 y déficits más graves; decisivo para literatura de timing.
Exploración neurológica completa	Reflejos rotuliano y aquileo; sensibilidad dermatomérica; Lasègue/SLR; marcha; marcha de talones/puntillas; coordinación si procede; tono; asimetrías.	Determinar radiculopatía y objetivar progresión.
Cauda equina: historia	Dificultad para iniciar micción; pérdida de sensación de flujo; retención; incontinencia; necesidad de sondaje; anestesia o hipoestesia perineal/en silla de montar; disfunción intestinal; alteración sexual de nueva aparición; síntomas radiculares bilaterales.	Los signos aislados tienen sensibilidad limitada y deben valorarse en conjunto. 20

Bloque de información	Campos concretos que deberían recuperarse	Razón de relevancia
Cauda equina: pruebas/exploración	Sensibilidad perineal documentada; exploración pertinente realizada; PVR si se midió, hora y volumen; situación pre/postmicción; sondaje.	PVR ayuda a estratificar pero no excluye CES por sí solo. ³⁷
Consulta del 02/06 completa	Texto íntegro, no extracto; anamnesis; exploración; diagnóstico diferencial; tratamiento; profesional; hora; indicaciones de seguimiento.	D2 reconoce que no reproduce la exploración neurológica completa. filecite[turn0file1]
Safety-netting del 02/06	Texto literal o plantilla utilizada para “motivos de reconsulta”; advertencias sobre debilidad, esfínteres, anestesia perineal, fiebre u otros signos; entrega de hoja escrita/SMS/app; constancia de comprensión.	Permite valorar el deber de información y si se dio una instrucción clínicamente adecuada. ²⁴
Contactos intermedios	Consultas presenciales, urgencias, teléfono, teleconsulta, enfermería o mensajes entre 2-11 de junio; fechas/horas y motivo.	Puede cambiar completamente la reconstrucción temporal.
Nota del 11/06 íntegra	Profesional, hora, antecedentes, examen, decisión clínica; significado exacto de “reevaluar y derivar para valoración”.	El extracto no contiene la medida objetiva de fuerza ni la valoración posterior. filecite[turn0file1]
Derivación del 11/06	Servicio destinatario; urgente/preferente/ordinaria; hora de envío y recepción; respuesta; rechazo/redirección; fecha de valoración; informe resultante.	Determinar si la respuesta clínica fue más amplia que simplemente “esperar la RM”.
Petición original de RM	Formulario electrónico completo; indicación clínica; diagnóstico de sospecha; síntomas transcritos; nivel anatómico; modalidad; contraste/no contraste; peticionario.	D3 declara que el formulario no está disponible en el extracto. filecite[turn0file0]
Trazabilidad temporal de la orden	Fecha/hora de creación; guardado provisional; firma; emisión; envío; recepción por radiología; registro; primera revisión/triage; modificaciones posteriores; identidad del usuario que modifica.	Resuelve la controversia 10 vs 12 de junio y permite aplicar correctamente el RD 605/2003. ⁸
Prioridad asignada	Urgente/emergente/preferente/ordinaria; código informático; criterios locales de cada categoría; quién la asignó y cuándo; cambios de prioridad.	Distingue cumplimiento de circuito programado de adecuación clínica.

Bloque de información	Campos concretos que deberían recuperarse	Razón de relevancia
Protocolos locales vigentes en junio de 2025	Protocolo de lumbalgia/radiculopatía; protocolo CES; criterios para RM urgente; definición de déficit motor significativo; política de priorización radiológica; circuito fuera de horario.	Es la comparación más directa con la práctica exigible en ese centro.
Gestión de cita	Fecha/hora de primera oferta; 16/06 como asignación; fecha propuesta inicialmente; posibles huecos; rechazos o cambios del paciente; incidencias; derivación a otro centro.	Distinguir demora estructural de demora atribuible a paciente o decisión clínica.
Comunicaciones al paciente	SMS, llamadas, cartas, portal, fecha de notificación; instrucciones si empeoraba mientras esperaba.	Valorar continuidad y <i>safety-netting</i> .
RM de 24/06	Fecha/hora exacta; protocolo; imágenes DICOM; niveles afectados; tamaño/ localización de hernia; compresión radicular; estenosis; compresión de cauda equina; otras patologías.	Sin imagen/informe no puede comprobarse la hipótesis anatómica.
Informe radiológico	Informe original, provisional y definitivo; fecha/hora de dictado, validación y disponibilidad; autor; hallazgos críticos.	D3 dice que el resultado no está incorporado y que el informe no se aportó. filecite:turn0file0
Comunicación de resultado crítico	Sistema de alertas; llamada a clínico; hora; receptor; instrucciones; confirmación de lectura.	Una RM oportuna puede perder valor si un hallazgo crítico se comunica tarde.
Seguimiento del 26/06	Nota completa; síntomas; exploración objetiva; acciones realizadas mientras el informe estaba pendiente.	D2 sólo consigna que se esperaba el informe. filecite:turn0file1
Tratamiento entre 02/06 y 24/06	Analgesia y dosis; antiinflamatorios; corticoides si los hubo; rehabilitación; actividad recomendada; respuesta; efectos adversos.	Reconstruir manejo conservador y evolución independiente de la RM.
Intervenciones posteriores	Valoración traumatología/neurocirugía; infiltración; cirugía; indicación y fecha; prioridad; hallazgos intraoperatorios.	Determinar si una RM anterior habría cambiado una intervención efectiva.
Evolución motora posterior	MRC después del 24/06, al alta y en seguimientos; marcha, pie caído, sensibilidad, esfínteres.	Esencial para análisis de daño y causalidad.
Situación laboral	Profesión; tareas concretas; carga física; conducción, sedestación, manejo de pesos; adaptaciones posibles.	“Limitación para trabajar” depende de las exigencias reales del puesto.

Bloque de información	Campos concretos que deberían recuperarse	Razón de relevancia
Incapacidad temporal	Partes oficiales de baja, confirmación y alta; diagnóstico codificado; facultativo emisor; fechas; revisiones.	La reclamación refiere 03/06–15/07 pero no aporta documentos. filecite turn0file2
Resultados funcionales	ODI, Roland-Morris, EVA/NRS de dolor si existen; capacidad de marcha/ sedestación; sueño; actividades básicas.	Permite cuantificar daño y evolución, no sólo narrarlo.
Auditoría del sistema de información	Logs inmutables de historia, RIS/PACS, petición electrónica y agendas; fecha de altas/modificaciones posteriores.	Protege frente a errores derivados de impresiones o extractos generados meses después.
Normativa autonómica	CCAA, servicio de salud, decreto/orden de garantías vigente en junio de 2025, cartera y plazos aplicables a RM.	Sin CCAA no puede decidirse cumplimiento de una garantía regional concreta.
Análisis de incidente, si existe	Notificación de seguridad, revisión interna, comité de calidad, análisis causa-raíz, reclamación/respuesta del centro.	Puede revelar información organizativa no presente en la HC.
Daño y causalidad	Dictamen pericial si existe; secuela objetiva; situación basal; causas alternativas; duración atribuible específicamente al supuesto retraso.	Necesario para separar desviación asistencial de daño causal.

Hay, además, cuatro documentos concretos cuya ausencia es especialmente crítica porque los propios extractos la reconocen: **formulario original de petición de imagen, informe radiológico original, registro completo de derivación y documentación de incapacidad temporal.** filecite turn0file0
filecite turn0file1

Conclusiones y recomendaciones para la inspección

Valoración técnico-bibliográfica provisional

Primera conclusión: la fecha de la RM no puede juzgarse sin clasificar el riesgo neurológico. La evidencia contemporánea a junio de 2025 desaconsejaba la imagen rutinaria inmediata para lumbalgia/ radiculopatía sin signos de alarma, pero apoyaba investigación rápida cuando existía déficit neurológico grave/progresivo o sospecha de cauda equina. ³⁸

Segunda conclusión: el expediente disponible no contiene el dato que permite efectuar esa clasificación. Existe una referencia subjetiva y posteriormente registrada a “menor fuerza”, pero no consta en D2 la cuantificación MRC, una exploración neurológica completa ni el informe de la valoración a la que se decidió derivar al paciente. filecite turn0file1 Por ello, no es metodológicamente defendible reconstruir a posteriori “MRC 3”, “pie caído”, “debilidad leve” o “exploración normal”: todas esas hipótesis excederían la documentación.

Tercera conclusión: hay dos escenarios inspectores razonablemente opuestos.

Escenario reconstruido con la HC completa	Interpretación probable
Dolor lumbar/radicular; fuerza objetivamente normal o déficit mínimo, estable, no progresivo; sin alteración esfinteriana/perineal/ bilateral ni otros <i>red flags</i> .	La evidencia no respaldaba RM inmediata de rutina. Un estudio realizado el 24/06 podría ser compatible con una estrategia conservadora/preferente, y no sería posible inferir daño simplemente por no haberse hecho antes. ¹
Déficit motor objetivo nuevo y progresivo, especialmente de magnitud relevante, caída funcional marcada, o datos compatibles con cauda equina.	La evidencia disponible ya favorecía reevaluación urgente, imagen y derivación especializada rápida. Un itinerario de RM ambulatoria programada 13-14 días después podría resultar clínicamente inadecuado, según intensidad, progresión y protocolos vigentes. ³⁹

Cuarta conclusión: la cifra “12 días” no debe confundirse con el estándar clínico. Es verdad que 12 días desde el registro del 12/06 hasta el 24/06 encajan numéricamente dentro de los 15 días de la categoría “preferente” del RD 605/2003. ⁷ Pero el propio RD define esos conceptos para el sistema de información de listas de espera, y una emergencia neurológica no queda convertida en asistencia adecuada por cumplir un umbral administrativo de consulta/prueba preferente. ⁸

Quinta conclusión: ni siquiera está cerrada la fecha inicial del cómputo. El paciente recuerda solicitud el 10/06; el registro contiene asiento el 12/06; D3 aclara que no conoce la fecha de emisión clínica. ^{filecite[turn0file2]} ^{filecite[turn0file0]} Dado que el RD 605/2003 conceptualiza la fecha de entrada como fecha de indicación del médico, la orden original y su *audit trail* son pruebas prioritarias. ⁸

Sexta conclusión: la documentación de información al paciente merece una revisión propia. La expresión “se explican motivos de reconsulta” no es equivalente a ausencia de información, pero el extracto no permite comprobar qué se dijo. ^{filecite[turn0file1]} La Ley 41/2002 impone que la información clínica sea comprensible y adecuada y prevé que se deje constancia de ella. ²⁴ Para una reclamación centrada precisamente en que no se supo cuándo reconsultar, debe examinarse el contenido completo y no sólo la fórmula resumida.

Séptima conclusión: con los documentos actuales no puede establecerse causalidad entre el intervalo y la baja laboral. La reclamación afirma incapacidad del 3 de junio al 15 de julio, pero no aporta partes; tampoco se dispone del informe de RM ni de un diagnóstico confirmado, evolución motora seriada o tratamiento posterior. ^{filecite[turn0file2]} ^{filecite[turn0file1]} La literatura permite plantear que la demora importa en ciertos déficits motores importantes, pero no demuestra que cada día de espera en cualquier radiculopatía prolongue necesariamente la incapacidad. ⁴⁰

Octava conclusión: la evidencia posterior a junio de 2025 refuerza, pero no debe retroproyectarse. La actualización española de Essencial de 2026 formula de modo explícito la separación entre lumbalgia/radiculopatía sin signos de alarma —sin imagen en las primeras 4-6 semanas— y déficits neurológicos graves/progresivos —situación que justifica imagen—. ²⁹ Es útil como corroboración de que la distinción sigue vigente, pero la inspección debe valorar la conducta de junio de 2025 con fuentes y protocolos disponibles entonces.

Recomendación operativa de inspección

Actuación	Recomendación
Preservación documental	Requerir historia clínica íntegra y exportación de metadatos de HC, petición electrónica, RIS/PACS y agenda, evitando basar el dictamen final exclusivamente en D1-D3.
Reconstrucción temporal	Elaborar una línea de tiempo minuto/día a día con síntomas, exploraciones, orden clínica, registro, triage, asignación, RM, informe y comunicación.
Clasificación neurológica	Determinar, si la documentación lo permite, fuerza MRC, progresión, raíz, repercusión funcional y presencia/ausencia documentada de signos de cauda equina.
Verificación de protocolo contemporáneo	Recuperar la versión exacta vigente en junio de 2025 del protocolo del centro/servicio de salud para lumbalgia, radiculopatía, déficit motor y CES.
Separación clínica/administrativa	Analizar por separado si hubo cumplimiento de plazos administrativos y si la prioridad clínica fue adecuada. Un resultado no sustituye al otro.
Auditoría del safety-netting	Establecer el contenido concreto de los “motivos de reconsulta” explicados el 02/06 y si incluían empeoramiento neurológico/esfinteriano.
Correlación radiológica	Revisar personalmente el informe original y, ante controversia, las imágenes, identificando si existía lesión capaz de explicar la debilidad.
Análisis contrafactual del daño	Sólo tras conocer RM, fuerza, tratamiento y evolución, preguntar si una imagen/derivación anterior habría cambiado probablemente el manejo y el resultado.
Normativa autonómica	Identificar la CCAA antes de emitir una conclusión sobre tiempos máximos legalmente garantizados.
Uso de evidencia posterior	Etiquetarla expresamente como “posterior al hecho” y utilizarla únicamente como corroboración/contexto, nunca como obligación retroactiva.

La **pregunta inspectora final**, una vez completado el expediente, debería formularse de manera semejante a esta:

En una persona con lumbalgia irradiada que el 10-11 de junio de 2025 refirió nueva disminución de fuerza, ¿la anamnesis, exploración neurológica, información de alarma, derivación, prioridad asignada y tiempo hasta la RM fueron acordes con la gravedad objetivamente documentada y con los protocolos y evidencia vigentes en junio de 2025, y existe evidencia de que una eventual desviación temporal produjo un daño clínico diferencial?

Esa formulación evita presuponer tanto la existencia de una urgencia neurológica como su inexistencia.

Bibliografía verificable — formato Vancouver, selección prioritaria

1. España. **Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.** Boletín Oficial del Estado. Artículos 4, 15 y 16. 6
2. España. **Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.** Boletín Oficial del Estado. 41
3. España. **Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.** Boletín Oficial del Estado. 26
4. National Institute for Health and Care Excellence. **Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. NG59.** London: NICE; 2016, actualización 2020. 12
5. American College of Radiology. **ACR Appropriateness Criteria: Low Back Pain.** Variante de lumbalgia aguda sin *red flags* y variante de sospecha de cauda equina. 13
6. Chou R, Fu R, Carrino JA, Deyo RA. **Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis.** Lancet. 2009;373(9662):463-472. doi:10.1016/S0140-6736(09)60172-0. 10
7. Gilbert FJ, Grant AM, Gillan MGC, Vale LD, Campbell MK, Scott NW, et al.; Scottish Back Trial Group. **Low back pain: influence of early MR imaging or CT on treatment and outcome—multicenter randomized trial.** Radiology. 2004;231(2):343-351. doi:10.1148/radiol.2312030886. 11
8. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, Brand R, Eekhof JAH, Tans JTJ, et al. **Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica.** N Engl J Med. 2007;356(22):2245-2256. doi:10.1056/NEJMoa064039. 16
9. Overdevest GM, Vleggeert-Lankamp CLAM, Jacobs WCH, Brand R, Koes BW, Peul WC, et al. **Recovery of motor deficit accompanying sciatica—subgroup analysis of a randomized controlled trial.** Spine J. 2014;14(9):1817-1824. doi:10.1016/j.spinee.2013.07.456. 4
10. Dionne N, Adefolarin A, Kunzelman D, Trehan N, Finucane L, Levesque L, et al. **What is the diagnostic accuracy of red flags related to cauda equina syndrome, when compared to MRI? A systematic review.** Musculoskelet Sci Pract. 2019;42:125-133. doi:10.1016/j.msksp.2019.05.004. 20
11. Katzouraki G, Zubairi AJ, Hershkovich O, Grevitt MP. **A prospective study of the role of bladder scanning and post-void residual volume measurement in improving diagnostic accuracy of cauda equina syndrome.** Bone Joint J. 2020;102-B(6):677-682. doi:10.1302/0301-620X.102B6.BJJ-2020-0195.R1. 21
12. Kögl N, Brawanski K, Girod PP, Petr O, Thomé C. **Early surgery determines recovery of motor deficits in lumbar disc herniations—a prospective single-center study.** Acta Neurochir (Wien). 2021;163(1):275-280. doi:10.1007/s00701-020-04614-0. 17

13. Thomé C, Kögl N, Grassner L, Vo AK, Kramer JLK, Petr O. **Motor Recovery Depends on Timing of Surgery in Patients With Lumbar Disk Herniation.** Neurosurgery. 2022;90(3):347-353. doi: 10.1227/NEU.0000000000001825. ¹⁸
14. Todd N, Dangas K, Lavy C. **Post-void bladder ultrasound in suspected cauda equina syndrome—data from medicolegal cases and relevance to magnetic resonance imaging scanning.** Int Orthop. 2022. doi:10.1007/s00264-022-05341-0. ²³
15. **Predictive value of post-void residual volume as an adjunctive tool in the clinical evaluation of cauda equina syndrome.** Bone Joint J. 2023. Revisión sistemática/metaanálisis de 1.083 pacientes. ²²
16. Getting It Right First Time, NHS England. **Interactive pathway to help diagnose and treat Cauda Equina Syndrome without delay.** 2023. ³
17. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Essencial. **Pruebas de imagen en lumbalgia.** Publicación original 2013; actualización abril de 2026. ⁴²
18. GuíaSalud; Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. **No solicitar o no repetir pruebas de imagen en pacientes con dolor crónico si no existen signos de alarma o cambios en la patología.** 2026. ³⁰
19. Thavarajasingam SG, et al. **Indications for surgery versus conservative treatment in the management of lumbar disc herniations: a systematic review.** 2025. La revisión describe heterogeneidad sustancial en los umbrales de déficit motor y momento quirúrgico. ³¹
20. Getting It Right First Time, NHS England. **New research provides evidence of the efficacy of GIRFT's national pathway and guidance for suspected cauda equina syndrome.** 2025; resumen oficial de la evaluación de implementación de Thiagarajah et al. ³²

En su estado actual, el expediente RP-DEMO-01 permite identificar una **señal inspectora legítima** — nueva sensación de menor fuerza seguida de una RM casi dos semanas después—, pero **no contiene los elementos clínicos ni administrativos necesarios para convertir esa señal en una conclusión de incumplimiento o de causalidad**. La prioridad probatoria es recuperar la exploración neurológica, la petición original con su trazabilidad, el circuito de derivación y prioridad, y el informe/imágenes de RM; sólo después resulta científicamente defendible confrontar el caso con la evidencia contemporánea de junio de 2025.

¹ ¹⁰ ³⁶ ³⁸ Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19200918/?utm_source=chatgpt.com

² ¹³ ³⁴ Preview
https://acsearch.acr.org/docs/69483/Narrative/?utm_source=chatgpt.com

³ Interactive pathway to help diagnose and treat Cauda Equina Syndrome without delay is now live - Getting It Right First Time - GIRFT
https://gettingitrightfirsttime.co.uk/interactive-pathway-to-help-diagnose-and-treat-cauda-equina-syndrome-without-delay-is-now-live/?utm_source=chatgpt.com

- 4 19 40 Recovery of motor deficit accompanying sciatica--subgroup analysis of a randomized controlled trial.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24200407/?utm_source=chatgpt.com
- 5 17 39 Early surgery determines recovery of motor deficits in lumbar disc herniations-a prospective single-center study - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33145630/?utm_source=chatgpt.com
- 6 24 25 BOE-A-2002-22188 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
<https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188&p=20210605&tn=0>
- 7 27 BOE-A-2003-11266 Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11266&utm_source=chatgpt.com
- 8 41 BOE-A-2003-11266 Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.
<https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/05/23/605/con>
- 9 Ministerio de Sanidad - Profesionales - Calidad Asistencial - Excelencia clínica
https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/excelenciaClinica/?utm_source=chatgpt.com
- 11 Low back pain: influence of early MR imaging or CT on treatment and outcome--multicenter randomized trial - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15031430/?utm_source=chatgpt.com
- 12 Recommendations | Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management | Guidance | NICE
<https://www.nice.org.uk/guidance/NG59/chapter/recommendations>
- 14 Pruebas de imagen en lumbalgia. Esencial
https://essencialsalut.gencat.cat/es/detalls/Article/proves_imatge_lumbalgia_2013?utm_source=chatgpt.com
- 15 Osakidetza archivos - GuíaSalud
https://portal.guiasalud.es/entidad-financiadora/osakidetza/?utm_source=chatgpt.com
- 16 Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17538084/?utm_source=chatgpt.com
- 18 Motor Recovery Depends on Timing of Surgery in Patients With Lumbar Disk Herniation - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35040807/?utm_source=chatgpt.com
- 20 What is the diagnostic accuracy of red flags related to cauda equina syndrome (CES), when compared to Magnetic Resonance Imaging (MRI)? A systematic review.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31132655/?utm_source=chatgpt.com
- 21 A prospective study of the role of bladder scanning and post-void residual volume measurement in improving diagnostic accuracy of cauda equina syndrome.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32475252/?utm_source=chatgpt.com
- 22 37 Predictive value of post-void residual volume as an adjunctive tool in the clinical evaluation of cauda equina syndrome.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37121596/?utm_source=chatgpt.com

23 35 Post-void bladder ultrasound in suspected cauda equina syndrome-data from medicolegal cases and relevance to magnetic resonance imaging scanning - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35182176/?utm_source=chatgpt.com

26 BOE-A-2011-14190 Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-14190&p=20110829&tn=1&utm_source=chatgpt.com

28 American College of Physicians Issues Advice for High-Value Health Care for Diagnostic Imaging for Low Back Pain | ACP Online

https://www.acponline.org/acp-newsroom/american-college-of-physicians-issues-advice-for-high-valuehealth-care-for-diagnostic-imaging-for?utm_source=chatgpt.com

29 42 Pruebas de imagen en lumbalgia. Essencial

https://essentialsalut.gencat.cat/es/detalls/Article/proves-imatge-lumbalgia?utm_source=chatgpt.com

30 No solicitar o no repetir pruebas de imagen en pacientes con dolor crónico si no existen signos de alarma o cambios en la patología - GuíaSalud

https://portal.guiasalud.es/no-hacer/no-solicitar-pruebas-imagen/?utm_source=chatgpt.com

31 Indications for surgery versus conservative treatment in the management of lumbar disc herniations: A systematic review - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41078967/?utm_source=chatgpt.com

32 New research provides evidence of the efficacy of GIRFT's national pathway and guidance for suspected cauda equina syndrome (CES) - Getting It Right First Time - GIRFT

https://gettingitrightfirsttime.co.uk/new-research-provides-evidence-of-the-efficacy-of-girfts-national-pathway-and-guidance-for-suspected-cauda-equina-syndrome-ces/?utm_source=chatgpt.com

33 Best practice tool supports primary care colleagues to assess and manage patients with spinal pain - Getting It Right First Time - GIRFT

https://gettingitrightfirsttime.co.uk/best-practice-tool-supports-primary-care-colleagues-to-assess-and-manage-patients-with-spinal-pain/?utm_source=chatgpt.com